【临床康复】

百会八阵穴针刺联合 Schuell 刺激法治疗卒中后运动性失语症患者的效果

郭美美，王旭红，杨彩洁
（漯河医学高等专科学校第三附属医院神经康复科，河南　漯河　462000）

【摘要】 **目的：**观察百会八阵穴针刺联合 Schuell 刺激法治疗卒中后运动性失语症患者的效果。**方法：**选取 2022 年 2 月至 2023 年 7 月该院收治的 80 例卒中后运动性失语症患者进行前瞻性研究，按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各 40 例。对照组予以 Schuell 刺激法治疗，观察组在对照组基础上联合百会八阵穴针刺治疗。比较两组临床疗效，治疗前后语言沟通能力 [中国式功能性语言沟通能力检测法（CFCP）]、认知功能 [Loewenstein 认知功能评定量表（LOTCA）]、生命质量 [卒中和失语症生活质量量表（SAQOL-39）] 评分。**结果：**观察组治疗总有效率为 87.50%（35/40），高于对照组的 67.50%（27/40），差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗后，两组 CFCP 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗后，两组 LOTCA 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗后，两组 SAQOL-39 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论：**百会八阵穴针刺联合 Schuell 刺激法治疗卒中后运动性失语症患者可提高治疗总有效率和语言沟通能力、认知功能、生命质量评分，效果优于单纯 Schuell 刺激法治疗。

【关键词】 百会八阵穴针刺；Schuell 刺激法；卒中；运动性失语症；语言功能；语言沟通能力；认知功能
doi:　10. 3969 / j. issn. 1672-0369. 2025. 07. 034
中图分类号： R255.2　　**文献标识码：** B　　**文章编号：** 1672-0369（2025）07-0112-03

Effects of Baihui Bazhen point acupuncture combined with Schuell stimulation on patients with post-stroke motor aphasia

GUO Meimei, WANG Xuhong, YANG Caijie
(Department of Neurorehabilitation of the Third Affiliated Hospital of Luohe Medical College, Luohe 462000 Henan, China)

【**Abstract**】 **Objective:** To observe effects of Baihui Bazhen point acupuncture combined with Schuell stimulation in treatment of patients with post-stroke motor aphasia. **Methods:** A prospective study was conducted on 80 patients with post-stroke motor aphasia admitted to this hospital from February 2022 to July 2023. According to the random number table method, they were divided into control group and observation group, 40 cases in each group. The control group was treated with Schuell stimulation, while the observation group was treated with Baihui Bazhen point acupuncture on the basis of that of the control group. The clinical efficacies and the scores of the verbal communication ability [Chinese functional verbal communication ability test (CFCP)], cognitive function [Loewenstein cognitive function rating scale (LOTCA)], quality of life [stroke and aphasia quality of life scale (SAQOL-39)] were compared between the two groups before and after the treatment. **Results:** The total effective rate of the observation group was 87.50% (35/40), which was higher than 67.50% (27/40) of the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). After the treatment, the CFCP scores of the two groups were higher than those before the treatment, that in the observation group was higher than that in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). After the treatment, the LOTCA scores of the two groups were higher than those before the treatment, that in the observation group was higher than that in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). Further, after the treatment, the SAQOL-39 scores of the two groups were higher than those before the treatment, that in the observation group was higher than that in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). **Conclusions:** Baihui Bazhen point acupuncture combined with Schuell stimulation can improve the total effective rate of treatment and the scores of verbal communication ability, cognitive function and quality of life in the patients with post-stroke motor aphasia. Moreover, it is superior to simple Schuell stimulation.

【**Keywords**】 Baihui Bazhen point acupuncture; Schuell stimulation method; Stroke; Motor aphasia; Language function; Verbal communication ability; Cognitive function

运动性失语症是卒中后常见的并发症，临床表现为言语表达障碍 [1]。Schuell 刺激法是临床常用的康复训练方法，但单一应用疗程较长，且疗效欠佳。中医学将运动性失语症归属于“风懿”“不语”等范畴，因风邪侵袭经络，气血不畅，痰蒙心窍所致 [2]，应以通络醒神为治则。百会八阵穴针刺以百会穴为中心选穴，对相应区域进行针刺，可调节经脉气血、振奋阳气 [3]。本文观察百会八阵穴针刺联合 Schuell 刺激法治疗卒中后运动性失语症患者的

收稿日期：2024-03-21
作者简介：郭美美（1990.09—），女，汉族，河南漯河人，本科，主管技师，研究方向为康复治疗。

中国知网　https://www.cnki.net

效果。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取 2022 年 2 月至 2023 年 7 月本院收治的 80 例卒中后运动性失语症患者进行前瞻性研究。纳入标准：西医符合卒中后运动性失语症诊断标准[4]；经头颅 CT、磁共振成像等检查确诊；中医符合风痰阻络证诊断标准[5]，证见言语不利、言语謇涩或不语、舌红、苔黄腻、脉浮或弦滑；语言表达障碍，但语言理解力较好。排除标准：卒中前存在认知、精神及心理障碍；先天性神经功能障碍、语言障碍；入组前 1 个月接受失语症相关治疗；对本研究治疗方法存在禁忌证；中途退出。患者及家属均知情本研究内容并签署知情同意书，本研究经本院医学伦理委员会批准（批准文号：2021010012）。按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各 40 例。对照组：男 21 例，女 19 例；年龄 49~81 岁，平均（67.98 ± 2.36）岁；病程 14~168 d，平均（45.86 ± 13.54）d。观察组：男 23 例，女 17 例；年龄 48~80 岁，平均（68.01 ± 2.39）岁；病程 15~170 d，平均（45.90 ± 13.51）d。两组一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05），有可比性。

1.2　方法　对照组予以 Schuell 刺激法治疗。（1）听觉刺激锻炼：准备不同的图册，说出词语由患者选定图片进行匹配。（2）发音锻炼：指导患者进行口形与声音支配控制唇舌运动，由声母、韵母逐渐过渡至近似音，由单音节逐渐过渡至多音节。（3）语言表达锻炼：指导患者逐步开展词、句、段训练，通过发音、辅助、命名、表达等方式反复进行，由易至难，对患者的错误反应给出提示，向功能障碍较严重的患者主动示范发音口型、舌头位置、发音技巧等。以上锻炼方法 45 min/ 次，5 次 / 周，连续治疗 4 周。

观察组在对照组基础上联合百会八阵穴针刺治疗。以百会穴为中心，百会穴至印堂穴间的距离为半径制圆，将圆周 8 等分，对应穴位顺时针依次为天乾、风巽、蛇坎、云艮、地坤、龙震、离鸟、兑虎。嘱患者取舒适坐位，对 8 个穴位进行消毒，使用 0.25 mm × 40 mm 的一次性使用无菌针灸针针刺天乾，而后以逆时针方向针刺剩余 7 个穴位，均朝百会穴方向斜刺 15 mm，得气后行子午捣臼法，留针 20 min，1 次 /d，5 次 / 周，连续治疗 4 周。

1.3　观察指标　（1）比较两组临床疗效。显效：治疗后，患者言语不利、言语謇涩或不语等症状明显改善，汉语失语症成套测验（ABC）评分提高 ≥ 60%；有效：治疗后，患者症状有所改善，30% ≤ ABC 评分提高 <60%；无效：治疗后，患者症状无明显变化，ABC 评分提高 <30%。总有效率 =（显效 + 有效）例数 / 总例数 × 100%。（2）比较两组治疗前后语言沟通能力评分。治疗前和治疗 4 周后，采用中国式功能性语言沟通能力检测法（CFCP）评估，共 5 个维度，25 个条目，每个条目 0~10 分，总分 0~250 分，评分越高表明语言沟通能力越好。（3）比较两组治疗前后认知功能评分。治疗前和治疗 4 周后，采用 Loewenstein 认知功能评定量表（LOTCA）评估，共 26 个条目，总分 0~115 分，评分越高表明认知功能越好。（4）比较两组治疗前后生命质量评分。治疗前和治疗 4 周后，采用卒中和失语症生活质量量表（SAQOL-39）评估，包括生理、心理社会、交流 3 个维度，共 39 个条目，每个条目 0~4 分，总分 0~156 分，评分越高表明生命质量越高。

1.4　统计学方法　采用 SPSS 22.0 统计学软件处理数据，计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，采用 t 检验，计数资料以率（%）表示，采用 χ^2 检验，以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组临床疗效比较　观察组治疗总有效率为 87.50%（35/40），高于对照组的 67.50%（27/40），差异有统计学意义（P<0.05）。见表 1。

表 1　两组临床疗效比较 [n（%）]

组别	显效	有效	无效	总有效率
观察组（n=40）	15（37.50）	20（50.00）	5（12.50）	35（87.50）
对照组（n=40）	10（25.00）	17（42.50）	13（32.50）	27（67.50）
χ^2 值				4.588
P值				0.032

2.2　两组治疗前后语言沟通能力评分比较　治疗前，两组 CFCP 评分比较，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组 CFCP 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 2。

2.3　两组治疗前后认知功能评分比较　治疗前，两组 LOTCA 评分比较，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组 LOTCA 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 3。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　两组治疗前后语言沟通能力评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	CFCP 评分		t 值	P 值
	治疗前	治疗后		
观察组（n=40）	110.24 ± 8.52	167.05 ± 10.23*#	26.988	0.000
对照组（n=40）	110.20 ± 8.50	148.79 ± 9.08*	19.623	0.000
t 值	0.021	8.443		
P 值	0.983	0.000		

注：与治疗前比较，*P<0.05；与对照组比较，#P<0.05

表 3　两组治疗前后认知功能评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	LOTCA 评分		t 值	P 值
	治疗前	治疗后		
观察组（n=40）	30.28 ± 3.51	73.17 ± 6.26*#	37.796	0.000
对照组（n=40）	30.25 ± 3.49	62.05 ± 5.42*	31.199	0.000
t 值	0.038	8.494		
P 值	0.970	0.000		

注：与治疗前比较，*P<0.05；与对照组比较，#P<0.05

2.4　两组治疗前后生命质量评分比较　治疗前，两组 SAQOL-39 评分比较，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组 SAQOL-39 评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 4。

表 4　两组治疗前后生命质量评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	SAQOL-39 评分		t 值	P 值
	治疗前	治疗后		
观察组（n=40）	77.50 ± 9.87	129.53 ± 15.22*	18.140	0.000
对照组（n=40）	76.26 ± 10.35	112.26 ± 12.34*#	14.137	0.000
t 值	0.548	5.574		
P 值	0.585	0.000		

注：与治疗前比较，*P<0.05；与对照组比较，#P<0.05

3　讨论

卒中后运动性失语症患者表现为口齿不清、发音困难或语言不流利等，其具有理解与阅读能力，可通过康复治疗进行改善。Schuell 刺激法已广泛应用于失语症患者的语言康复中，通过听觉刺激、多角度语言刺激等可恢复或重建患者的语言功能[6]，但卒中后运动性失语症病因复杂，单用 Schuell 刺激法治疗无法达到满意效果。

中医学认为，卒中后运动性失语症病机系风、痰、瘀上扰清窍，脑神闭阻致舌强不语。百会穴属督脉，具有开窍醒神、益气升阳的功效，针刺以百会穴为中宫的八阵穴可疏通经络、平衡阴阳[7-8]。本研究结果显示，观察组治疗总有效率高于对照组。分析原因为天乾为印堂穴，属督脉，通于脑，针刺该穴位可醒脑开窍、宁心安神；地坤与天乾相对，针刺该穴位可改善患者语言功能；针刺兑虎可化痰、通络、益气；针刺风巽可祛风除邪；针刺蛇坎、离鸟可协调经脉阳气；针刺云艮、龙震可改善气血平衡[9-10]。因此，针刺百会八阵穴可发挥通络开窍、温阳益气、疏风化痰的功效，联合 Schuell 刺激法可有效改善患者失语症症状，提高治疗效果。

本研究结果同时显示，治疗后，观察组 CFCP、LOTCA、SAQOL-39 评分均高于对照组。分析原因为百会八阵穴针刺有利于刺激大脑皮层，增强神经细胞兴奋性，从而改善患者语言功能和认知功能[11]，联合 Schuell 刺激法可进一步促进语言功能和神经功能的恢复，从而提高生命质量[12]。

综上所述，百会八阵穴针刺联合 Schuell 刺激法治疗卒中后运动性失语症患者可提高治疗总有效率和语言沟通能力、认知功能、生命质量评分，效果优于单纯 Schuell 刺激法治疗。

参考文献

[1] 沈琳，陆李还，俞建锋，等 . 针芒行气法结合弩法治疗运动性失语的临床研究 [J]. 上海医药，2021，42（14）：23-25.
[2] 徐丽霞，王丽君，张璐 . 活血通络方联合言语康复训练治疗中风后失语临床研究 [J]. 新中医，2022，54（11）：88-91.
[3] 钟欢 . 针刺百会八阵穴治疗脑卒中后失语症的临床研究 [J]. 中国医学创新，2023，20（1）：99-103.
[4] 詹青，王丽晶 . 2016 AHA/ASA 成人脑卒中康复治疗指南解读 [J]. 神经病学与神经康复学杂志，2017，13（1）：1-9.
[5] 国家中医药管理局 . 中医病证诊断疗效标准 [M]. 北京：中国医药科技出版社，2012：35-38.
[6] 汪瑛，汪节，陈少飞 . 电针配合 Schuell 刺激法治疗中风后失语的临床研究 [J]. 湖南中医药大学学报，2020，40（4）：465-468.
[7] 李雪青，邓娟娟，熊丽，等 . 通络醒神针法联合缪刺法治疗脑卒中后运动性失语症临床研究 [J]. 天津中医药大学学报，2023，42（1）：24-28.
[8] 陈健林，傅晓峰，倪新元，等 . 百会八阵穴联合圣愈汤对脑卒中后失语症患者的疗效及脑血流的影响 [J]. 中国中医急症，2023，32（9）：1583-1586.
[9] 马志辉，杨艳君，刘兢，等 . 不同针刺方法治疗阴虚风动型脑梗死后运动性失语症的平行对照研究 [J]. 四川中医，2019，37（5）：176-178.
[10] 李文茜，虞军，王春燕，等 . 通窍开音针联合语言康复训练治疗中风后运动性失语临床研究 [J]. 针灸临床杂志，2020，36（7）：16-20.
[11] 扈洁，郑德松，刘云东，等 . 针刺百会八阵穴对缺血性脑卒中运动性失语患者语言功能及脑血流的影响 [J]. 山东中医杂志，2021，40（9）：957-961.
[12] 刘渝册，马志辉，杨艳君，等 . 不同针刺方案治疗脑卒中后失语症的临床研究 [J]. 广州中医药大学学报，2019，36（2）：219-222.

编辑：李婷婷

中国知网　https://www.cnki.net